

## Syndrome de Gougerot-Sjogren

### I. Définition – intérêt de la question :

- Maladie auto-immune, caractérisée par une infiltration lympho-plasmocytaire et une destruction des glandes exocrines salivaires et lacrymales conduisant à une perte des fonctions sécrétoires « xérostomie, xérophtalmie »
- Maladie systémique pouvant atteindre plusieurs organes : articulations, système nerveux, poumon, reins
- Syndrome de Sjogren isolé « primitif », ou associé à d'autres connectivites
- Maladie invalidante « altération de la qualité de vie », parfois le pronostic vital est mis en jeu

### II. Épidémiologie – physiopathologie :

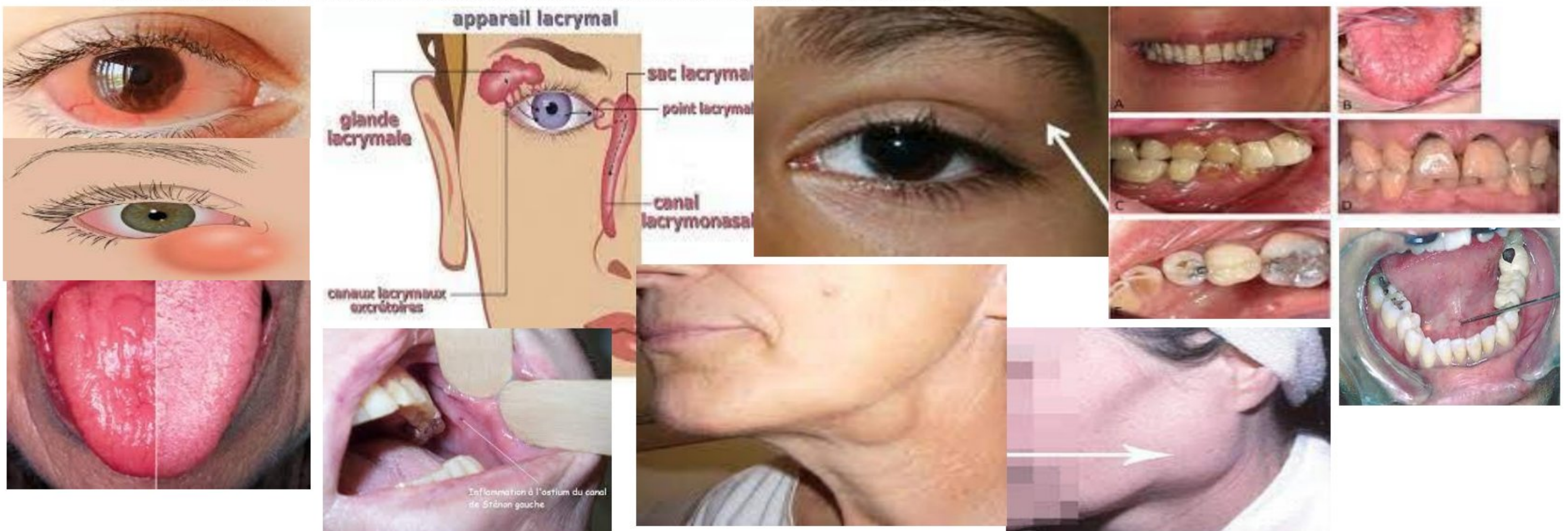
- Connectivite la plus fréquente, nette prédominance féminine : « sexe ratio : 1/9 », âge : 40 - 60 ans « en moyenne 50 ans »
- **Multifactorielle** : facteurs génétiques, environnementaux (infections bactériennes ou virales) → activation des cellules épithéliales et réponse excessive du **système interféron** « IFN » « présent chez plus 50% patients dans le sang et les tissus cibles » → production excessive par les cellules épithéliales de la **cytokine BAFF** qui stimule la maturation et la survie des lymphocytes B
- L' **hyperactivation des LB** : se traduit par la présence d'auto-anticorps : Anti- SSA, anti- SSB, facteur rhumatoïde et d'une hyper-gammaglobulinémie
- La signature interféron, l'hyperactivation des lymphocytes B et T : cibles thérapeutiques

### III. Diagnostic positif :

#### 1. Clinique :

##### • Manifestations glandulaires « Sécheresse » :

- **Atteinte oculaire « Xérophtalmie »** : sensation de sable ou de corps étranger dans les yeux, douleurs oculaires, démangeaisons, irritation et rougeur oculaire, hypertrophie des glandes lacrymales dacryocystite, conjonctivite, épisclérite
- **Atteinte buccale « Xérostomie »** : sensation de bouche sèche, difficulté à avaler et nécessité de prendre de l'eau pour avaler, épisodes d'hypertrophie parotidienne bilatérale récidivante  
Examen clinique : muqueuse sèche, ulcérée, collante, brillante ou au contraire bien humidifiée, langue lisse, décapillée, fissurée, rouge, avec brûlures « stomatodynie », candidose  
Examen des tissus parodontaux : saignement, œdème ou récession des gencives, plaques caries dentaires  
Hypertrophie des glandes salivaires principales « parotides et sous-maxillaires » : examen des orifice de Sténon et de Wharton
- **Test au sucre** : morceau de sucre doit fondre en moins de 3 minutes



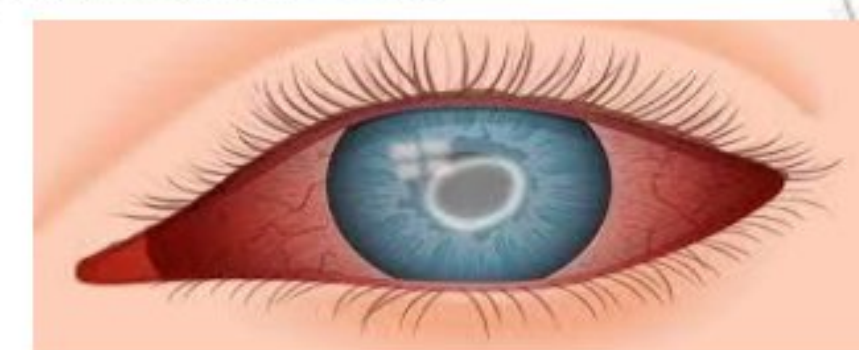
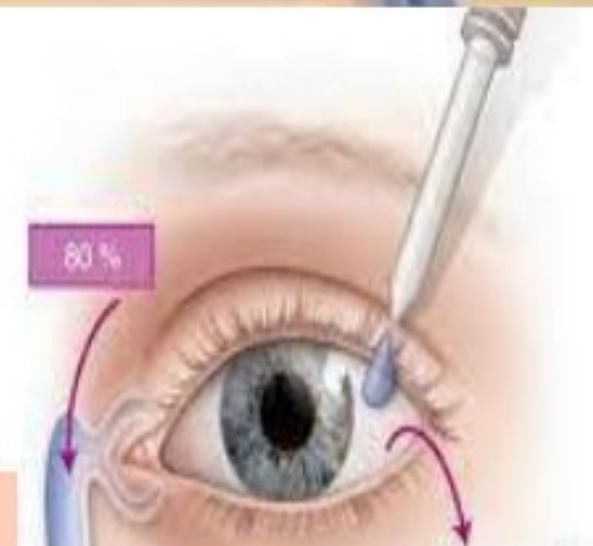
- **Atteinte cutanée « Xérose »** : infiltration lymphoïde des glandes sudorales, hyposudation peut être également liée à une neuropathie des petites fibres ; prurit, picotements sensation de brûlures, tiraillement  
Manifestations fréquentes : syndrome de Raynaud, purpura hyper-gammaglobulinémique, vascularite cryoglobulinémique
- **Atteinte de la muqueuse respiratoire** : rhinite, croutes endonasales, bronchite



- **Atteinte de la muqueuse génitale** : sécheresse vaginale , prurit, ulcérations, candidose, dyspareunie
- **Manifestations extra-glandulaires : « atteintes systémiques »**
  - **Signes généraux** : asthénie +++, amaigrissement modéré, la fièvre oriente plutôt vers une complication
  - **Atteinte articulaire** : polyarthralgies inflammatoires des grosses moyennes et petites articulations, non déformantes et non destructrices
  - **Atteinte broncho-pulmonaire** : toux sèche chronique, dyspnée d'effort progressive, dyspnée asthmatiforme : atteinte bronchique ou bronchilaire « syndrome obstructif à l'EFR », pneumopathie infiltrante diffuse « syndrome restrictif »
  - **Atteinte neurologique** : mononeuropathie multiple, polyneuropathie sensitive ou sensitivo - motrice, atteinte des paires crâniennes « trijumeau++ », ganglionopathie polyradiculonévrite chronique, atteinte dysautonomique. Atteintes centrales : pseudo-SEP, neuromyéélite optique, vascularite du système nerveux central, myélite
  - **Atteinte rénale** : néphropathie tubulo-interstitielle « acidose métabolique hyperchlorémique hypokaliémie, hypercalciurie, sans ou avec altération de la fonction rénale, plus rarement glomérulaire
  - **Atteinte musculaire** : avec ou sans élévation des enzymes musculaires
  - **Atteinte hématologique** : lymphopénie « signe d'activité », plus rarement neutropénie, thrombopénie auto-immune, anémie hémolytique auto-immune
  - **Atteinte digestive** : rare

## 2. Paraclinique :

- **Objectiver la xérophtalmie** :
  - Test de Schirmer pathologique : « < 5mm /5mn »
  - Temps de rupture du film lacrymal : pathologique si < 5 secondes  
Instillation d'une goutte de fluorceine et mesurer le temps nécessaire à l'apparition de la première zone de rupture du film lacrymal après clignement
  - Recherche d'une kérato -conjonctivite superficielle, Ulcère cornéen
- **Objectiver la xérostomie** :
  - Biopsie des glandes salivaires accessoires : une sialadénite lymphocytaire chronique
- **Diagnostic immunologique** :
  - AC anti-nucléaires « FAN » : IFI sur cellule HEp2
  - AC anti -SSA « Ro 52 , Ro 60 »
  - AC anti- SSB « La »
- **Autres signes biologiques** :
  - Lymphopénie
  - Hypergammaglobulinémie polyclonale



## IV. Diagnostic différentiel :

- **Devant une sécheresse buccale ou oculaire** :
  - **Médicaments** : atropine, antidépresseurs, neuroleptiques, antiparkinsoniens, morphiniques, antalgiques opiacés, anticholinergiques, cannabis, tabac, cocaïne, bêta- et alpha- bloquants, benzodiazépines
  - **Irradiation locale**
  - **Terrain** : diabète déséquilibré, déshydratation, dysthyroïdie, hépatite C, B, sarcoïdose, amylose, syndromes dépressifs
- **Devant une parotidomégalie** :
  - **Causes ORL** : parotidite aigue ou chronique : lithiase, virale « ourliennes, CMV », Suppurée, tumeurs bénignes ou malignes
  - **Causes générales** : sarcoïdose, maladie à IgG4, lymphome, diabète, cirrhose éthylique,

## V. Diagnostic de gravité :

- **Altération de la qualité de vie** : asthénie, sécheresse, douleur
- **Complications locales** :
  - **Oculaires** : kératite ponctuée superficielle, ulcère et perforation cornéenne, blépharite
  - **Buccales** : caries dentaires, candidoses, détérioration dentaire, parodontopathies
- **Complications systémiques** :
  - **Dégénérescence lymphomateuse B** : Altération de l'état général, fièvre, parotidomégalie persistante, syndrome tumoral, pic monoclonal des gammaglobulines, cryoglobulinémie de type 1

- **Vascularite cryoglobulinémique** : purpura vasculaire, phénomène de Raynaud, multinévrite sensitive, glomérulonéphrite, normo ou hypo-gammaglobulinémie
- **Atteinte pulmonaire** : PID et risque de fibrose pulmonaire
- **Atteinte neurologique**
- **Atteinte rénale** : risque d'insuffisance rénale chronique terminale → **Traitement spécifique**
- **Gougerot et grossesse** : BAV congénital, lupus néonatal « anti-SSA , anti-SSB »

## VI. Principes du traitement :

- **Objectifs :**

- Améliorer la qualité de vie des patients : « asthénie , douleur, sécheresse »
- Préserver le pronostic vital et fonctionnel « atteintes systémiques »

- **Moyens :**

- Traitement symptomatique de la sécheresse : non pharmacologique et pharmacologique « sécrétagogues »
- Traitement spécifique des atteintes systémiques : corticothérapie systémique, immunosuppresseurs, immunomodulateurs, biothérapie
- Éducation thérapeutique

### 1. Modalités thérapeutiques :

- **Sécheresse buccale :**

- Bonbons acides sans sucres, chewing-gum sans sucre, agrumes, auto- massage parotidien,
- Agonistes muscariniques « **pilocarpine** » à **dose progressives**, également efficace sur la sécheresse nasale, bronchique et vaginale
- Substituts salivaires : gel, spray, bain de bouche
- Mesures hygiéniques : brossage régulier fluoré des dents, éviter : tabac, alcool, caféine,
- Traitement des candidoses bucco-pharyngées

- **Sécheresse oculaire** : larmes artificielles, gels lubrifiants, collyre de corticoïdes,

- **Prise en charge gynécologique de la sécheresse vaginale** : règles d'hygiène, lubrifiants

### 2. Modalités du suivi :

- **Objectifs :**

- Préciser l'activité et la sévérité de la maladie
- Dépister des atteintes viscérales infracliniques
- Évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements
- Rechercher une éventuelle comorbidité
- Évaluer les facteurs de risque vasculaires, infectieux et de lymphome

- **Rythme des consultations :**

- L'activité initiale, les atteintes viscérales, comorbidités, le type des traitements prescrits, grossesse

- **Sur le plan clinique :**

- Examen de la bouche à la recherche de complications locales, contrôle ophtalmologique périodique
- Examen des parotides et des sous-maxillaires
- Recherche de signes généraux, de signes d'activité articulaires, neurologiques, auscultation pulmonaire, recherche d'un syndrome tumoral, effets secondaires des traitements

- **Examens paracliniques :**

- Formule sanguine « cytopénies », EPP « composant monoclonal », fonction rénale, chimie des urines, ionogramme sanguin et urinaire, protéinurie des 24h, sédiment urinaire, un bilan hépatique, recherche d'une complication du traitement « ostéodensitométrie, bilan phosphocalcique »

- **En cas de suspicion d'un lymphome** : échographie parotidienne, immunofixation protéines plasmatiques, dosage des chaînes légères libres plasmatiques, cryoglobulinémie, nouvelle biopsie des glandes salivaires accessoire ou biopsie parotidienne ou d'adénopathie.